Тезисы
VII Конгресса педиатров стран СНГ
«Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания»

23–24 октября 2015 г.
Сочи, Краснодарский край, Россия
SEA GALAXY Hotel

Организаторы Конгресса

- Федерация педиатров стран СНГ
- Министерство здравоохранения Российской Федерации
- Министерство здравоохранения Краснодарского края
- Управление здравоохранения Администрации города Сочи
- Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов (Россия)
- Национальное научное общество инфекционистов (Россия)
- Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины
- Российская Ассоциация педиатрических центров
- Ассоциация педиатров Украины
- Ассоциация акушеров-гинекологов и неонатологов Республики Беларусь
- Российская ассоциация детских хирургов
- Союз педиатров Казахстана
- Объединение педиатров республики Кыргызстан
- Ассоциация педиатров Армении
- Ассоциация перинатальной медицины Республики Молдова
- Ассоциация педиатров Таджикистана
- Ассоциация педиатров Узбекистана
- Глобальная инициатива по консенсусу в педиатрии и детскому здоровью (CIP)

Организационный комитет

Сопредседатели:

Козлова Л.В. (Россия), Яковлева Т.В. (Россия), Филиппов Е.Ф. (Россия), Каганов Б.С. (Россия)

Члены комитета:

Алексеенко С.Н. (Россия)
Ахмедова Д.И. (Узбекистан)
Болотова Н.В. (Россия)
Вартазарян М.А. (Россия)
Вохидов А.В. (Таджикистан)
Вильчук К.У.(Беларусь)
Диканбаева С.А. (Казахстан)
Гаращенко Т.И. (Россия)
Гольберг Е.Н. (Россия)
Горелов А.В. (Россия)
Зейгарник М.В. (Россия)
Ильенко Л.И. (Россия)
Кованова Н.Н. (Россия)
Левченко Т.И. (Россия)
Майданник В.Г. (Украина)
Мизерницкий Ю.Л. (Россия)
Михайлова Е.В. (Россия)
Перепелкина Т.Н. (Россия)
Покровский В.И. (Россия)
Разумовский А.Ю. (Россия)
Ревенко Н.Е. (Молдова)
Романец И.В. (Россия)
Терентьева Л.О. (Россия)
Узакбаев К.А. (Киргизия)
Школьникова М.А. (Россия)
Шуляк Г.А. (Россия)
Эрдес С.И. (Россия)

Научный комитет

Сопредседатели:

Володин Н.Н. (Россия), Геппе Н.А. (Россия), Камилов А.И. (Узбекистан), Румянцев А.Г. (Россия)

Члены комитета:

Антипкин Ю.Г. (Россия)
Валиулис А. (Литва)
Бельмер С.В. (Россия)
Боа-Очоа Х. (Испания)
Джубатова Р.С. (Узбекистан)
Кароли М. (Италия)
Кац М. (Израиль)
Лобзин Ю.В. (Россия)
Маркетти М. (Италия)
Мещеряков В.В. (Россия)
Палий И.И. (Молдова)
Сафронова А.Н. (Россия)
Скрипченко Н.В. (Россия)
Строкова Т.В. (Россия)
Студеникин В.М. (Россия)
Сукало А.В. (Беларусь)
Улезко Е.А. (Беларусь)
Умарова З.С. (Узбекистан)
Хайтович Н.В. (Украина)
Шадрин О.Г. (Украина)
Шамсиев Ф.М. (Узбекистан)

стентности. С другой стороны, учитывая то, что апелин является фактором, предотвращающим развитие гипертрофии миокарда и его сократительной дисфункции, повышение его содержания может играть положительную адаптационную роль.

У детей 2-й группы уровень кортизола был статистически значимо ниже в сравнении с детьми из 1 группы и соответствовал показателю группы контроля. Также у детей 2-й группы отмечено более чем двукратное снижение концентрации инсулина в крови и индекса инсулинорезистентности в сравнении как с детьми из СРЦ, так и с детьми контрольной группы. У детей из детских домов была статистически значимо снижена концентрация резистина (4,99 ± 0,32 vs 7,16 ± 0,7 нг/мл), что, вероятно, и явилось причиной развития высокой сенситивности к инсулину. Также отмечалось еще более выраженное, по сравнению с 1-й группой, снижение содержания лептина (2,69 ± 0,4 нг/мл).

Таким образом, адипокиновый профиль у детей в трудной жизненной ситуации отражает адаптационные сдвиги, позволяющие обеспечить мобилизацию липидов и кардиопротекцию в условиях стресса с последующим формированием регуляторных настроек на компенсацию нутритивного дефицита. Вместе с тем данные механизмы адаптации несут и опасность развития метаболического синдрома, что делает особенно актуальным формирование стереотипов здорового образа жизни и пищевого поведения в персонифицированных программах реабилитации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Эффективность ЭХОКГ-исследования при выявлении немых форм пролапса митрального клапана у детей

Шильманова А.Б., Мамырбаева М.А., Исмамбетова Г.К., Кушаева А.М., Туякбаев А.М., Сыдыгалиева З.М.

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. Марата Оспанова, Актобе, Республика Казахстан

В детском возрасте пролапс митрального клапана выявляется по данным ВОЗ у 3–15% детей и чаще всего встречается в возрасте от 7 до 15 лет, преимущественно страдают девочки. С точки зрения этиологического подхода разграничивают первичный и вторичный пролапс митрального клапана. По локализации пролабирования выделяют пролапс передней, задней и обеих створок митрального клапана. С учетом наличия и отсутствия выслушиваемых звуковых феноменов говорят о «немой» и аускультативной форме синдрома.Имеются определенные трудности в диагностике «немых» форм пролапса митрального клапана.

Цель исследования: оценить эффективность Эхо-кардиографического исследования при выявлении немых форм пролапса митрального клапана у детей в возрасте до 15 лет.

Пациенты и методы. Были проведены Эхо-кардиографические исследования детей в возрасте до 15 лет за последние 3 года (2013–2014–2015 гг.) с изменениями на ЭКГ в виде возникновения нарушений процесса реполяризации (уплощение или инверсия зубца Т, смешение сегмента ST). Основные диагнозы при направлении на эхокардиографическое исследование: ВСД, гипервентиляционный синдром. Жалобы были больше неврологического характера, в частности в виде чувства нехватки воздуха, страха. Для уточнения диагноза и дифференциальной диагностики проводились ЭХО-кардиографические исследования. Всего было обследовано 750 детей. Из них преобладали девочки 485 (64,6%) и 265 мальчиков (35,4%). Средний возраст детей составил 10 ± 3,5 года. Из 750 детей пролапс митрального клапана был выявлен у 122 детей (16% от общего количество детей). При этом немая форма ПМК была зафиксирована в 57 случаях, что составляет 46,7% от всех выявленных случаев ПМК. При этом минимальный возраст обследованных детей составлял 2–3 года, максимальный возраст 14–15 лет.

Особо учитывались при ЭХОКГ типы пролабирования и глубина провисания створок.Таким образом, основными критериями для постановки диагноза пролапса митрального клапана, наряду с клинической картиной в виде жалоб неврологического характера были следующие эхокардиографические изменения:

1. Выгибание одной или обоих створок за линию коаптации (проекцию митрального отверстия) в парастернальной проекции длинной оси левого желудочка или проекции 4 камер с верхушки.
2. Умеренная утолщенность и избыточность створок.
3. Увеличение площади митрального отверстия (более чем 4 см^2)
4. Избыточная экскурсия левого атриовентрикулярного кольца.

Заключение: Эхокардиография в диагностике пролапса митрального клапана является наиболее физиологичным и высокоинформативным методом исследования по сравнению с другими инвазивными (ангиокардиогафия) и неинвазивными (фонокардиография) методами.

Профилактика ОРВИ у часто болеющих детей

Шит С.М., Ревенко Н.Е.

Государственный университет медицины и фармации им. Н.Тестемицану, Кишинев, Республика Молдова

Детей, чаще, чем их сверстники, подверженных ОРВИ объединяют в группу диспансерного наблюдения «часто болеющие дети» (ЧБД). Целью работы является профилактика ОРВИ и их осложнений у ЧБД препаратом Кагоцел – индуктором интерферонов (НИАРМЕДИК ПЛЮС, Россия). У детей в возрасте от 3 до 7 лет в качестве критерия для включения в группу ЧБД использовали инфекционный индекс (ИИ), определяемый как отношение суммы всех случаев ОРВИ в течение года к возрасту ребенка: ИИ = (сумма всех случаев ОРВИ в течение года)/(возраст ребенка в годах). Под наблюдением находилось 90 ЧБД с 3 до 7 лет с 2013 по 2015 гг. Дети были разделе-